

Chalazión

Es la inflamación crónica de una glándula sebácea (de Meibomio), que se manifiesta como una tumoración redondeada e indolora en la placa tarsal. Puede perforarse y formar un granuloma piógeno.

Orzuelo

Es la inflamación aguda del folículo piloso de las pestañas y de las glándulas de Zeiss y Moll.

A diferencia del chalazión es doloroso y está más cerca del borde palpebral.

Tratamiento

- Pomadas con antibióticos (eritromicina o tobramicina) y corticoides.
- Quirúrgico en caso de chalazión grande que no responde al tratamiento tópico.

Antecedentes

De cuerpos extraños, traumatismos leves, uso de lentes de contacto, etc.

Signos y síntomas

{ Dolor
Lagrimeo
Disminución de la visión
Congestión conjuntival.

Las lesiones se pueden identificar mediante la instilación de fluoresceína, cuando se observa con lámpara de hendidura o si no contamos con ella, con buena iluminación y lupa (de 20 dioptrías) se puede observar que la superficie erosionada aparece teñida de color amarillo verdoso brillante.

El hallazgo de abrasiones corneales lineales obliga a realizar la búsqueda de un cuerpo extraño debajo del párpado superior. Se puede instilar anestesia tópica para facilitar la evaluación, pero no se debe continuar porque retrasa el proceso de reepitelización corneal.

Tratamiento

Tiene como finalidad promover la cicatrización y disminuir el dolor. En caso de ser muy pequeñas, puede ser tratada con aplicación frecuente de pomadas antibióticas sin corticoides (eritromicina 4 veces por día). Para las erosiones de mayor tamaño, se recomienda un parche a presión, previa colocación de po-

mada antibiótica, para inmovilizar los párpados y proteger el epitelio que está cicatrizando, contra el traumatismo constante del parpadeo, se cita al paciente para su control en 24 horas. Deben recibir vigilancia hasta que el epitelio cicatrice por completo.

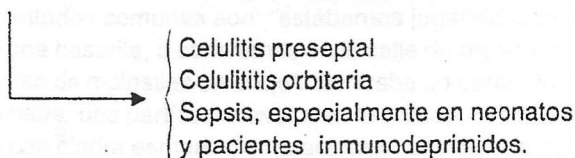
Si existe cuerpo extraño y no se dispone de lámpara de hendidura, puede intentarse la extracción del mismo mediante un aplicador de algodón impregnado de pomada oftálmica (ácido poliacrílico, eritromicina). Cuando el cuerpo extraño ha permanecido durante varias horas sobre la córnea, conviene ocluir con pomadas antibióticas y derivar al oftalmólogo.*

DACRIOCISTITIS AGUDA

Dra. Alejandra Tártara

Definición

Infección aguda del saco lagrimal. Requiere de rápido tratamiento debido a que el cuadro puede progresar a:



Síntomas

La infección aguda puede progresar en horas o días causando la **distensión del saco lagrimal**. **Eritema y dolor** en el sector nasal infraorbitario. Los niños y adultos inmunodeprimidos pueden desarrollar un cuadro de sepsis con compromiso del estado general.

El saco lagrimal inflamado puede drenar espontáneamente a través de una fístula por piel. Los microorganismos más frecuentes son el *estafilococo aureus* y *epidermidis*, *estreptococos* y *haemophilus influenzae*.

Tratamiento

Antibióticos vía oral y/o endovenosa dependiendo de la edad, el compromiso inmunológico y el estado clínico del paciente.

Tratamiento empírico cuando no hay compromiso orbitario

Cefalosporinas: - Cefalexina 50 -100 mg/kg/día cada 6 hs.

Pediatría Hospital Purrupato
Cefalexina 100 mg/kg/día cada 8 hs.

En neonatos, pacientes inmunodeprimidos, pacientes con compromiso orbitario y/o sepsis, el tratamiento requiere de internación con antibioticoterapia endovenosa, previa extracción de muestra para examen directo y cultivo, por aspiración percutánea o incisión del saco lagrimal Cefuroxima 150 mg/kg/día cada 8 horas.

El drenaje percutáneo es recomendable cuando el saco lagrimal está inflamado o distendido para la obtención de muestras para cultivo y aliviar el dolor.

Resuelto el cuadro inflamatorio se debe explorar la vía lagrimal para descartar obstrucción y evitar recidivas.*

CUERPO EXTRAÑO OCULAR

Dra. Marina Brussa

Si recibimos por guardia un niño con probable cuerpo extraño ocular, es útil primero escuchar a los padres, qué datos pueden aportarnos sobre lo ocurrido.

Comentarios comunes son: "estábamos jugando al aire libre y le entró una basurita, o caminando en la calle de repente comenzó a quejarse de molestias en el ojo". Si miraba un obrero trabajando puede haber una partícula clavada en la córnea, especialmente pulidores con piedra esmeril. Se tratará entonces de una partícula de metal, que es necesario extraer a la brevedad.

Mientras se conversa con los papás, observar la actitud del chico: cuando la córnea está comprometida viene cerrando un ojo por la fotofobia y se resiste a abrirlo por el dolor. Siempre es útil contar con un anestésico tópico (proparacaína o paenacaína) que disminuye inmediatamente estas molestias y permite examinarlo sentado frente a nosotros en la falda de su mamá.

Observaremos primero si la conjuntiva está normal o irritada, si hay secreción purulenta en los fondos del saco conjuntival, la pupila redonda centrada y negra, igual a la del otro ojo. Es importante porque cualquier alteración de estas estructuras no corresponde al diagnóstico de cuerpo extraño en el ojo externo, simplemente.

Primero intentaremos observar la córnea con una luz colocada de costado para iluminarla de forma tangencial y le hablamos para que no mire de frente. La examinamos para comprobar su transparencia y brillo regular en toda su superficie. Podemos ver directamente la partícula o una zona despulida y sin brillo que será la erosión que el cuerpo extraño ha causado. Buscar especialmente en la zona superior porque si hay una erosión allí, debemos buscar

el cuerpo extraño alojado debajo del párpado. Siempre conviene evertir el párpado superior, maniobra sencilla en los chicos. Para lograrlo lo tomamos por su borde libre entre las yemas de los dedos índice y pulgar y lo empujamos hacia abajo mientras colocamos el índice de la otra mano sobre la zona del pliegue palpebral. Tiramos ligeramente hacia fuera y arriba y conseguimos así la eversión. Si el cuerpo extraño está allí, basta con pasar un hisopo o un algodón o gasa y lo quitaremos. Cuando se encuentre enclavado en la córnea es más conveniente enviarlo al oftalmólogo, ya que éste utilizará el microscopio y prevendrá convenientemente la infección. Recordemos que la córnea es resistente pero delgada (1mm), por lo tanto es preferible utilizar mayor resolución para no causar una herida perforante en el intento de extraerlo. A veces tampoco un oculista puede y será necesaria la anestesia general.

También tenemos que tener en cuenta que una vez lesionado el epitelio, la córnea es un tejido muy débil y susceptible a la infección. Toda infección es potencialmente grave, ya que si cura dejando cicatriz, alterará su transparencia, y por ende disminuirá la visión, o en el peor de los casos puede conducir a endoftalmitis, con pérdida del globo ocular.

Es preferible la demora de una hora, poder darle las mejores posibilidades de un trato cuidadoso y experimentado. En este caso podemos cubrir con un antibiótico tópico y dedicar un momento a informar bien a los padres para que realicen la consulta más rápida posible.

Si la partícula no está fuertemente enclavada, puede despejarse mediante irrigación con suero fisiológico, en una jeringa sin aguja. Si logramos quitarla de este modo, también indicaremos colirio tópico para prevenir la infección. •

HIPEMA TRAUMÁTICO

Dra. Silvia Feuermann

Definición

Es la colección de sangre en la cámara anterior del globo ocular de origen traumático. Es una manifestación frecuente de las contusiones traumáticas graves, que nos hace sospechar lesiones asociadas.

Frecuencia e Incidencia

Más frecuente en varones y menores de 20 años.

Causas

Las causas más frecuentes son los golpes de puño, las piedras, palos, deportes en particular, paddle o tenis, armas de aires comprimido, gomeras.

Cuando no hay antecedentes de trauma, en los niños, debe sospecharse retinoblastoma, xantogranuloma juvenil, leucemia, trastornos de la coagulación o puede tratarse de un niño maltratado.

Valoración Clínica

Signos y Síntomas

- Nubosidad rojiza de diferente intensidad en cámara anterior
- Pupila irregular que reacciona lentamente cuando se la puede visualizar.
- Córnea opaca (por edema corneal)

- Congestión conjuntival
- Disminución de la presión intraocular (por shock ciliar) o aumento (por bloqueo angular)
- Disminución de la visión
- Dolor
- Somnolencia en los niños

Semiología

Hay que efectuar un interrogatorio cuidadoso acerca del tipo de traumatismo para buscar lesiones oculares asociadas y posibles antecedentes de diátesis hemorrágica previa, anemia falciforme, patología renal o hepática, tratamiento con anticoagulantes (aspirina).

Inspección del globo ocular y sus anexos, registrando anomalías en la posición del globo ocular. Se inspeccionan todo tipo de laceraciones y heridas punzantes en los párpados o en las cejas, equimosis o hemorragias periorbitarias y palpebrales.

Palpación: del reborde orbitario, buscar enfisema subcutáneo que indican fracturas orbitarias.

Agudeza visual: cuyo objetivo es obtener una estimación de la función visual.

Pupila: forma, localización, reflejos, excentricidad o irregularidad.

Motilidad ocular: presencia de diplopía durante los movimientos. Biomicroscopía, presión intraocular, gonioscopía y fondo de ojos: a realizar por el especialista.

Evolución

Si el hipema persiste y se acompaña de hipertensión ocular, requerirá tratamiento quirúrgico.

Complicaciones

Inmediatas

- Retroceso traumático del ángulo de la cámara anterior.
- Iridodiálisis o desinserción del iris
- Subluxación y luxación del cristalino

- Midriasis y miosis
- Hemorragia vítrea
- Desprendimiento de retina

Mediatas

- Resangrado del hipema
- Impregnación hemática de la córnea (si la hemorragia no se reabsorbe con rapidez, los pigmentos hemáticos penetran en la córnea y la tiñen, habitualmente coexisten con hipema total e hipertensión ocular).
- Glaucoma tardío
- Subluxación del cristalino

Tratamiento

- Reposo (dormir con almohada alta)
- Hospitalización (si hay resangrado)
- Atropina tópica y corticoides locales

Derivar al oftalmólogo para la indicación del tratamiento.

Control anual de presión ocular de por vida.

Conclusión

El hipema traumático debe considerarse siempre un signo grave, por las complicaciones inmediatas que acompañan al traumatismo, que pueden conducir a la pérdida de visión.

La complicación mediata es el Glaucoma. •